

TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA

Irene Padilla Conejo, Julio Tito Camino Acha

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS

Congénitos

Enfermedad De Von Willebrand

- Desorden hemorrágico hereditario más frecuente.
- Anomalía cuali y/o cuantitativa del factor de von Willebrand (FvW). El tipo más frecuente es el **Tipo 1**: déficit cuantitativo parcial del FvW (frecuencia del 70-80%).
- Clínica: gran variedad fenotípica, que conlleva **distintos grados de severidad**. Predominan los sangrados leves cutáneo-mucosos.
- Diagnóstico: alargamiento del tiempo de hemorragia y el TTPa; agregación plaquetaria y cifra de plaquetas normal.
- Tratamiento: desde DDAVP hasta concentrados plasmáticos de FvW y de r-FVIIa, según los distintos tipos y su severidad.

Hemofilia

- Déficit congénito de los factores **VIII** (hemofilia A) o **IX** (hemofilia B)
- Clasificación: grave (nivel de factor VIII o IX <1%), moderada (factor de 1-5%) y leve (>5%).
- Clínica: relación con la concentración del factor. La manifestación clínica más frecuente e importante es la **hemartrosis** (incidencia 90%), sobre todo en articulaciones de carga. En menor frecuencia, pueden aparecer hematomas musculares y hematuria
- Tratamiento: en hemorragias leves se puede administrar DDVAP, en los demás casos se debe emplear el **concentrado de factor VIII o IX**.

Adquiridos

Déficit Vitamina K

- La vitamina K es un cofactor necesario para carboxilar los residuos glutámicos de los precursores de los factores **II, VII, IX y X** y **proteínas C y S**. El aporte se realiza principalmente a través de la dieta y por las bacterias intestinales. Para su absorción se requiere una adecuada función biliar y pancreática.
- Causas: dieta deficiente, alteración de la absorción (obstrucción biliar, fibrosis quística, malabsorción intestinal...), ingesta de antagonistas de la vitamina K, enfermedad hepática...
- Clínica: poco sintomático. En casos severos pueden aparecer equimosis y hematomas subcutáneos y musculares junto con hemorragias mucosas.
- Analítica: alargamiento del TP y TTPA, que se normalizan tras la administración de vitamina K.
- Tratamiento: **vitamina K** (10 mg durante 3 días) por vía oral o por vía parenteral según la causa del déficit.

Coagulación Intravascular Diseminada (CID)

- Activación intravascular generalizada de la coagulación que ocasiona la formación de fibrina y la oclusión de vasos de pequeño y mediano calibre.
- Causas: **sepsis**, **traumatismos** graves, **cirugías** extensas, cáncer metastásico, leucemia promielocítica aguda, complicaciones obstétricas...
- Clínica: la principal es la **hemorragia**, que puede variar desde equimosis a sangrados mucosos que pueden llegar a ser graves. Por otra parte, el depósito de fibrina en la microcirculación, puede originar fenómenos **trombóticos** y afectar a órganos vitales,

produciendo **fallo multiorgánico**.

- Analítica: trombocitopenia y alteraciones microangiopáticas en el frotis. Alargamiento del TP y TTPA, aumento del dímero D, descenso de proteína C y S.
- Tratamiento: corregir la **causa** y tratamiento de **soporte** mediante plasma fresco congelado (PFC) y concentrados de plaquetas.

Inhibidores De Los Factores De Coagulación

- Anticuerpos dirigidos contra determinados factores de la coagulación; los más comunes se dirigen contra el factor VIII (hemofilia adquirida).

Hepatopatía Crónica

- Transtorno de la hemostasia por múltiples factores: defecto de síntesis de proteínas hemostáticas (factores II, V, VII, IX, X, XIII, antitrombina, proteína C y S), estado hiperfibrinolítico, trombopenia y trombopatía, insuficiencia renal, malabsorción intestinal...
- Clínica: las hemorragias suelen verse **precipitadas por complicaciones** de la propia enfermedad (rotura de varices esofágicas, cuadro séptico...)
- Analítica: descenso de los tiempos de coagulación, hipofibrinogenemia, descenso de proteína C, S y antitrombina, trombocitopenia y aumento de dímero D.
- Tratamiento: sólo en caso de hemorragia o ante maniobras invasivas; los más usados son vitamina K, DDAP y PFC

Coagulopatía Asociada A Fármacos

(ver en capítulo correspondiente)

HIPERCOAGULABILIDAD

Congénitos

- Trombosis en sujetos jóvenes, en localizaciones poco frecuentes y con tendencia a la recidiva. Carácter familiar.
- Tratamiento del episodio agudo: **anticoagulantes convencionales**. La duración debe individualizarse.

Factor de riesgo	Prevalencia en la población (%)
Déficit de antitrombina	0.02
Déficit de proteína C	0.2-0.5
Déficit de proteína S	0.1
Factor V Leiden heterocigoto	3-5
Factor V Leiden homocigoto	0.1
Protrombina G20210A	2-6
Hiperhomocisteinemia	5-10

Adquiridos

Factor de riesgo asociado al propio paciente	Factor de riesgo asociado a la situación clínica
Edad	Cirugía
Inmovilización	Traumatismos graves
ETEV previa	Neoplasia
Anticonceptivos orales	Insuficiencia cardíaca congestiva
Terapéutica hormonal sustitutiva	Enfermedad hematológica
Embarazo y puerperio	Anticuerpos antifosfolípidos

NOTA

- Nociones básicas para reconocer y tratar en Urgencias a pacientes con trastornos de la coagulación.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanz M, Carreras E (5º edición). Manual Práctico de Hematología Clínica 2014.
- Carlavilla A (6º edición). Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. MSD. https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/manual-12-octubre.xhtml?docId=1675